

Erste Hilfe, Notfälle und Reanimationsmaßnahmen

Modul 6: In Notfallsituationen angemessen Handeln
6.4 „Handeln in verschiedenen Notfallsituationen“
Unterrichtseinheiten: 4

Noah Diederich
Pflegefachmann



www.bzpg.de



1

Inhaltsverzeichnis

- Erste Hilfe
- Rechtliche Grundlagen
- Ampelschema
- Sofortmaßnahmen am Unfallort
- Rettungskette
- Seitenlage
- ABCDE- / GCS- / ISBAR-Schema
- 4H's + HITS
- Schockformen
- Basisreanimation
- Triage in der Notaufnahme
- Häufige Notfälle auf Station
- Injektionen

www.bzpg.de



2

Was ist Erste Hilfe?

„**Lebensrettende und gesundheitserhaltende Sofortmaßnahmen**, die **einfach erlernt** und bei **medizinischen Notfällen** [...] angewendet werden können.“

www.bzpg.de



3

Ziele der Ersten Hilfe

- **Leben retten:** Sofortige Maßnahmen wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) können das Überleben sichern
- **Schadensbegrenzung:** Durch richtige Handgriffe können Folgeschäden vermieden werden (z. B. Stabilisierung eines Knochenbruchs)
- **Ermöglichen weiterer Hilfe:** Vorbereitung des Patienten auf die professionelle medizinische Versorgung
- **Wichtig: Reaktionsfähigkeit und "sich trauen"**

www.bzpg.de



4

Was ist ein Notfall?

„Ein Notfall ist ein **plötzlich eingetretenes Ereignis**, das eine **unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit** des Patienten bedeutet. Die vitalen Funktionen sind durch Verletzung oder akute Erkrankung bedroht, gestört oder ausgefallen“

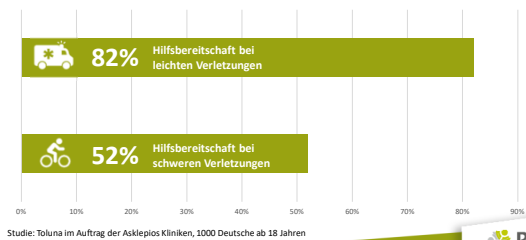
Quelle: Notfallmed. Begriffsdefinitionen (Kapitel 3), Notfallmedizin, Thieme

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

5

Statusreport Erste Hilfe



Studie: Toluna im Auftrag der Asklepios Kliniken, 1000 Deutsche ab 18 Jahren

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

6

Wer wird gerettet?

Faktoren, die es wahrscheinlicher machen Hilfe zu leisten:

- Ländliche Region
- Land mit niedrigerer wirtschaftlicher Entwicklung (gemessen an KKP)
- Gleiche ethnische Gruppenzugehörigkeit wie potenzielle Helfer
- Physische Attraktivität der hilfsbedürftigen Person
- Der gleichen sozialen Gruppe angehören
- Weibliches Geschlecht der hilfsbedürftigen Person
- Eindeutigkeit der Situation
- Potenzieller Helfer ist alleine bzw. wird nicht beobachtet

Quelle: Statusreport Erste Hilfe in Deutschland
(https://www.zfawachst.net/09m7qgpr02/S2p2X20m0m7V5uW450811u/ufR6u5080630486337363ad9d42471/Erste_Hilfe_Report.pdf)

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

7

Rechtliche Grundlagen

Wie ist die rechtliche Situation in Deutschland? Muss Erste Hilfe geleistet werden?

Recherchieren Sie in 2er-Gruppen, inwiefern Erste Hilfe geleistet werden muss und welche Konsequenzen drohen.

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

8

§ 323c Unterlassene Hilfeleistung; Behinderung von hilfeleistenden Personen – StGB

(1) Wer bei **Unglücksfällen** oder gemeiner **Gefahr** oder **Not** nicht **Hilfe leistet**, obwohl dies **erforderlich** und ihm den **Umständen nach zuzumuten**, insbesondere **ohne erhebliche eigene Gefahr** und **ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten** möglich ist, wird mit **Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr** oder mit **Geldstrafe bestraft**.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in diesen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will.

= In Deutschland besteht nach §323c StGB eine Pflicht zur Hilfeleistung bei Unfällen, wenn dies zumutbar ist. Unterlassene Hilfeleistung ist strafbar.

www.bzpg.de



9

§34 Unfall - StVO (Straßenverkehrs-Ordnung)

(1) Nach einem Verkehrsunfall hat, wer daran beteiligt ist,

1. unverzüglich zu halten,
 2. den Verkehr zu sichern und bei geringfügigem Schaden unverzüglich beiseite zu fahren,
 3. sich über die Unfallfolgen zu vergewissern,
 4. Verletzten zu helfen (§ 323c des Strafgesetzbuchs),
- [...]

www.bzpg.de



10

Garantenstellung

„**Garantenstellung** bezeichnet die Verpflichtung, das Pflegeangebot so zu gestalten, dass Schaden von der Person abgewendet wird, und zu garantieren, dass die Pflege nach dem heutigen Stand des Wissens, also nach neuesten Erkenntnissen, durchgeführt wird. Diese Verpflichtung gehen die Einrichtungsträger per Gesetz gegenüber der pflegebedürftigen Person und den Kostenträgern ein. Dazu bedarf es keiner zusätzlichen Vereinbarung.“

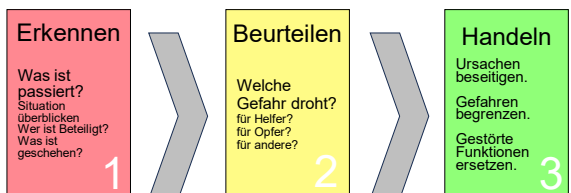
Quelle: Pflegeassistenz Heute, Kapitel 8, Elsevier

www.bzpg.de



11

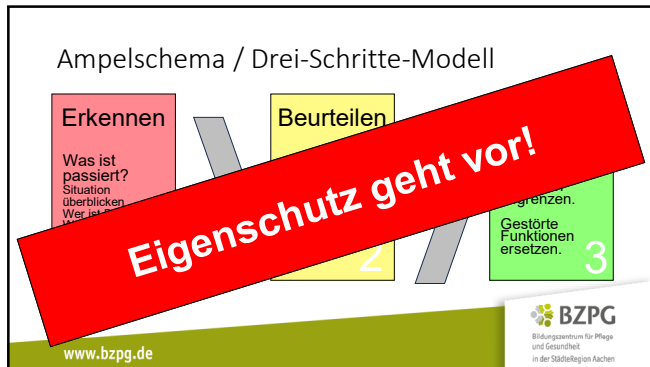
Ampelschema / Drei-Schritte-Modell



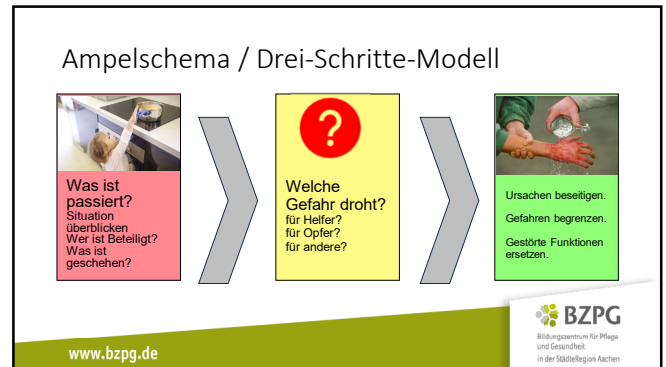
www.bzpg.de



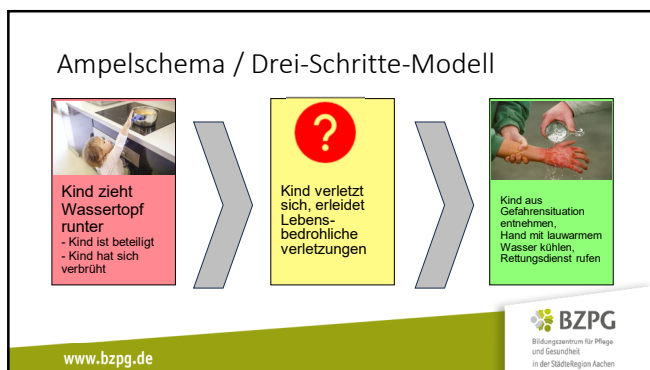
12



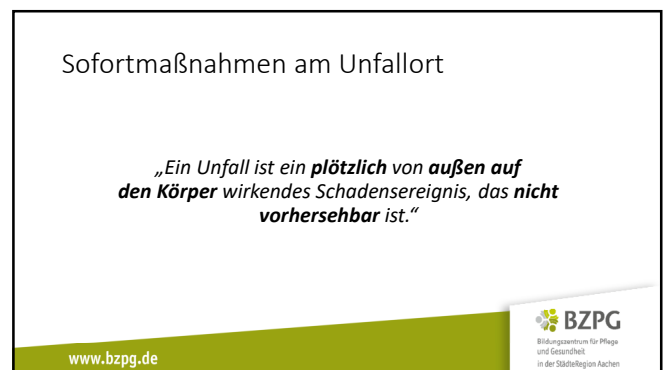
13



14



15



16

Sofortmaßnahmen am Unfallort

Brainstorming:

Was würden Sie an einer Unfallstelle tun?

www.bzpg.de



17

1: Überblick und Ziel

- **Ziel:** Leben retten und Folgeschäden minimieren, bis der Rettungsdienst eintrifft.
- **Priorität:** Eigenschutz und eine geordnete Hilfeleistung.
- **Vorgehen:** Notruf absetzen, Unfallstelle absichern, Erste Hilfe leisten.

www.bzpg.de



18

2: Gefahrenanalyse und Eigenschutz

- **Eigensicherung:** Eigene Sicherheit immer vor der des Verletzten
- **Gefahrenquellen beachten:** Verkehr, Feuer, Rauch, Elektrizität, gefährliche Stoffe, etc.
- **Schutzmaßnahmen:** Warndreieck aufstellen, Warnweste anziehen, Abstand zur Gefahrenquelle halten

www.bzpg.de



19

3: Absichern der Unfallstelle

Schritt 1: Warnblinker am eigenen Fahrzeug einschalten.

Schritt 2: Warnweste anziehen.

Schritt 3: Warndreieck aufstellen (ca. 100 m Abstand auf Autobahnen, 50 m im Stadtverkehr).

Schritt 4: Weitere Verkehrsteilnehmer warnen und eventuell die Polizei informieren.



Bildquelle: ADAC

www.bzpg.de



20

4: Überblick verschaffen und Betroffene beruhigen

- **Lage checken:** Wie viele Personen sind verletzt? Welche Art von Verletzungen gibt es?
- **Sprechen Sie Betroffene an:** Versichern, dass Hilfe unterwegs ist, um Angst und Panik zu mindern.

www.bzpg.de



21

5: Notruf absetzen

- **Notrufnummer: 112 (in ganz Europa gültig).**
- **Angaben machen:**
 - **Wo?** (genaue Adresse, Ortsangabe)
 - **Was?** (Art des Unfalls: Verkehrsunfall, Brand, etc.)
 - **Wie viele Verletzte?**
 - **Welche Art** von Verletzungen?
 - **Warten** auf Rückfragen



www.bzpg.de



22

6: 4Ws der Ersten Hilfe

- **Wärme:** Betroffene warmhalten (z. B. durch Decke), um Schock zu vermeiden
- **Wasserentzug vermeiden:** Keine Flüssigkeiten geben (besonders bei Bewusstlosigkeit)
- **Wach bleiben:** Regelmäßige Kontrolle der Vitalzeichen, Verletzte bei Bewusstsein halten
- **Warten auf professionelle Hilfe:** Ständige Überwachung und Beruhigung des Betroffenen

www.bzpg.de



23

7: Vitalzeichenkontrolle und Lagerung

- **Bewusstsein:** Reaktion prüfen (Ansprechen, leichte Berührungen)
- **Atmung:** Sichtbare Atmung oder hörbare Atemgeräusche
- **Kreislauf:** Puls an A. carotis, A. femoralis oder A. radialis fühlen, Hautfarbe und Temperatur beachten

www.bzpg.de



24

8: Lagerung

- **Bewusstlose Person (Seitenlage):**
 - Kopf überstrecken, Mund leicht öffnen, damit Erbrochenes ablaufen kann
 - Arme und Beine so positionieren, dass die Person stabil auf der Seite liegt
- **Person mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung:** Nicht bewegen, Kopf stabilisieren, warten auf professionelle Hilfe
- **Schocklagerung:** Beine hoch, Oberkörper flach

www.bzpg.de



25

Lebensrettende Sofortmaßnahmen

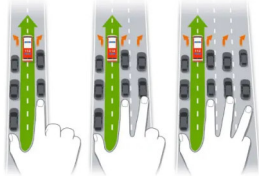
- **Absichern der Unfallstelle**
- **Retten aus der Gefahrenzone**
- **Absetzen eines Notrufs**
- **Herz-Lungen-Wiederbelebung / Reanimation**
- **Blutstillung**
- **Schockbekämpfung**
- **Seitenlage** (bei Bewusstlosigkeit)

www.bzpg.de



26

Rettungsgasse bilden



Bildquelle: DEKRA Roadsafety

www.bzpg.de



27

Rettungskette



www.bzpg.de



28

Was ist die Rettungskette?

- „Jede Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes Glied“
- Der schnellste Rettungsdienst und beste Arzt scheitern, wenn die Erste Hilfe versagt

www.bzpg.de



29

Schritt 1: Absichern und Eigenschutz

- Sicherstellen, dass kein weiterer Schaden entsteht und der Helfer geschützt ist
- Unfallstelle sichern (z. B. durch Warndreieck und Warnweste), mögliche Gefahrenquellen identifizieren und abwenden.
- Eigenschutz steht an erster Stelle, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

www.bzpg.de



30

Schritt 2: Absichern und Eigenschutz

- **Ziel:** Frühzeitige Alarmierung der Rettungskräfte, um die professionelle Hilfe schnellstmöglich zu starten.
- 112 anrufen, die **5 W-Fragen** beantworten:
 - Wo ist der Unfall?
 - Was ist passiert?
 - Wie viele Verletzte gibt es?
 - Welche Art von Verletzungen?
 - Warten auf Rückfragen.
- **Ruhig und präzise** bleiben, um die Informationen korrekt zu übermitteln

www.bzpg.de



31

Schritt 3: Erste Hilfe leisten

- **Ziel:** Sofortige Hilfe leisten, um lebensbedrohliche Zustände zu stabilisieren und das Überleben bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu sichern
- **Maßnahmen:**
 - **Vitalzeichenkontrolle** (Bewusstsein, Atmung, Kreislauf)
 - **Seitenlage** bei Bewusstlosigkeit und normaler Atmung.
 - **Reanimation** (30x Herzdruckmassage, 2x Beatmung) bei Atem- oder Kreislaufstillstand
 - **Wundversorgung** (Druckverband bei starken Blutungen).
 - **Schocklage** (Beine hochlagern, sofern keine Verletzungen im Bauchraum oder der Wirbelsäule bestehen)
- **Schutz:** Handschuhe oder Hilfsmittel, falls vorhanden, verwenden

www.bzpg.de



32

Schritt 4: Rettungsdienst

- Übergabe der medizinischen Versorgung an professionelles Rettungspersonal.
- **Maßnahmen:**
 - **Informationen geben:** Den Rettungskräften eine detaillierte Übergabe machen, z. B. Unfallhergang, Maßnahmen der Ersten Hilfe, besondere Verletzungen
 - **Kontrolle behalten:** Weiter betreuen, bis die Rettungskräfte eingetroffen sind
- **Ablauf:** Die Rettungskräfte übernehmen die weitere Versorgung, entscheiden über den Transport und bereiten die Aufnahme im Krankenhaus vor

www.bzpg.de



33

Schritt 5: Krankenhaus

- Vollständige **medizinische Versorgung** und **Rehabilitation** der Verletzten
- durch: **Untersuchungen, Behandlungen** (operativ, konservativ, rehabilitativ)
- Langfristige **Genesung sicherstellen** und **Folgeschäden vermeiden**

www.bzpg.de



34

Bewusstlosigkeit

"[...] gekennzeichnet durch **jegliches Fehlen von psychischem Geschehen mit aufgehobener Kontaktfähigkeit** und deutlich **eingeschränkter Reaktionsfähigkeit** bei **erhaltener somatischer Funktion**."

Quelle: DocCheck Flexion, 11.07.2024, <https://flexikon.doccheck.com/de/Bewusstlosigkeit>

- Keine Schutzreflexe (bspw. Schluck- oder Hustenreflex)
- Muskulatur erschlafft (CAVE: Erbrechen / Aspiration)

www.bzpg.de



35

Bewusstlosigkeit

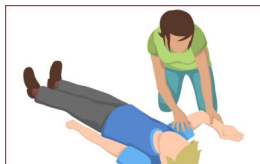
- 1) Hilfe rufen! Person laut ansprechen
- 2) Atmung prüfen (Hören - Sehen - Fühlen)
Wenn nicht: Reanimationspflichtig
- 3) Seitenlage

www.bzpg.de



36

Seitenlage – Schritt 1

**Arme positionieren:**

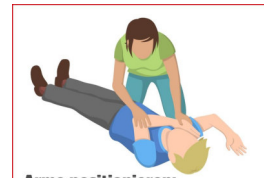
- Den nahen Arm anwinkeln, Handinnenfläche zeigt nach oben

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

37

Seitenlage – Schritt 1

**Arme positionieren:**

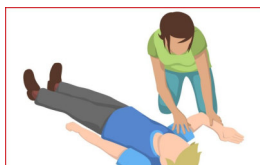
- Den anderen Arm vor der Brust kreuzen
- Handoberfläche an die Wange des Betroffenen legen

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

38

Seitenlage – Schritt 2

**Arme positionieren:**

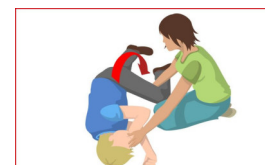
- Den nahen Arm anwinkeln, Handinnenfläche zeigt nach oben

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

39

Seitenlage – Schritt 3

**Herüberziehen:**

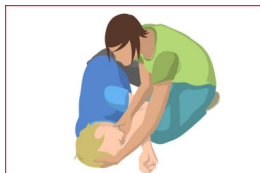
- Ziehe den Betroffenen zu dir rüber
- Oberschenkel steht im rechten Winkel zur Hüfte

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

40

Seitenlage – Schritt 4

**Mund öffnen:**

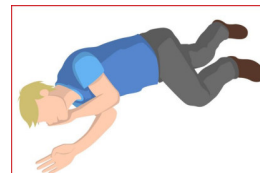
- Mund leicht öffnen und zum Boden ausrichten, um Erstickten zu vermeiden

www.bzpg.de

BZPG
 Bildungszentrum für Pflege
 und Gesundheit
 in der Städteregion Aachen

41

Seitenlage – Schritt 5

**Kopf überstrecken:**

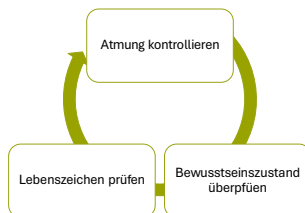
- Hand an der Wange so ausrichten, dass Kopf überstreckt bleibt

www.bzpg.de

BZPG
 Bildungszentrum für Pflege
 und Gesundheit
 in der Städteregion Aachen

42

Seitenlage – Schritt 6



www.bzpg.de

BZPG
 Bildungszentrum für Pflege
 und Gesundheit
 in der Städteregion Aachen

43

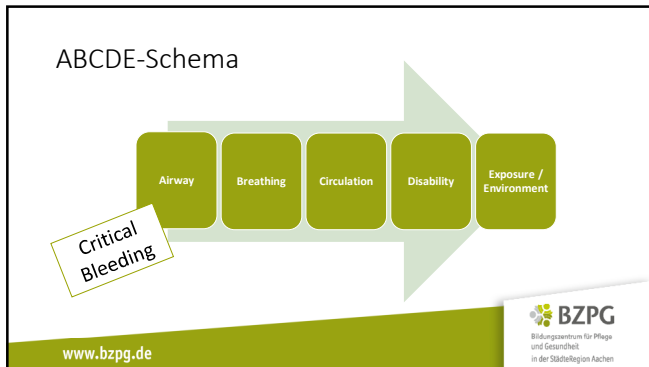
Strukturierte Patient:innenversorgung nach dem ABCDE-Schema

"Threat first, what kills first"

www.bzpg.de

BZPG
 Bildungszentrum für Pflege
 und Gesundheit
 in der Städteregion Aachen

44



45

xABCDE: eXsanguination/critical Bleeding
(lebensbedrohliche Blutung)

- Beherrschung der Hämorrhagie
- Starke Blutungen sichtbar?
 - Venös? Arteriell?
- Abdominelle Abwehrspannung?
- V. a. Beckentrauma?

Ein Patient, der zwar einen gesicherten Atemweg (Airway) hat, parallel aber verblutet, hat geringe bis keine Überlebenschancen.
- Interventionen:
 - Blutstillende Maßnahmen

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

46

ABCDE: Airway (Atmung)

- Atemwege frei?
- Atmung vorhanden?
- Risiko für Atemwegsverlegung oder -schwellung?
- HWS-Immobilisation?
- Interventionen:
 - Kopfreklination
 - Fremdkörperentfernung
 - Atemwegssicherung (Esmarch / Güdel / Wendt / Larynxmaske / Intubation)
 - Stabile Seitenlage?

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

47

ABCDE: Airway (Atmung)

Esmarch-Handgriff

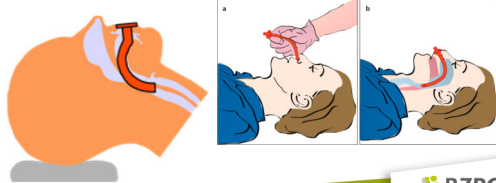
www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

48

ABCDE: Airway (Atmung)

Güdel-/ Wendltubus



www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

49

ABCDE: Airway (Atmung)

Güdel-tubus:

- Fest / verbiegen sich nicht

Wendltubus:

- deutlich geringerer Würgereiz
- Weich
- Weniger für Maskenbeatmung geeignet (Nasenbluten und ET-Tubuslagenkontrolle)
- Erleichtern die Spontanatmung

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

50

ABCDE: Breathing (Beatmung)

- Thoraxinspektion, -auskultation und -palpation
- gestaute Halsvenen?
- Zyanose
- SpO2?
- Kapnometrie

Interventionen:

- Atemunterstützende Lagerung
- O2-Gabe
- Assistierte/kontrollierte Beatmung

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

51

ABCDE: Circulation (Kreislauf)

- Puls? (Frequenz / Rhythmus / Qualität)
- Rekap-Zeit? (periphere Durchblutung – Schock)
- Blutdruck? (SYS / DIA / MAD – MAD < 60 mmHg = Organminderperfusion)
- Innere / äußere Blutungen?
- Fraktur großer Knochen? (Pelvis / Femur)

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

52

ABCDE: Circulation (Kreislauf)

Interventionen:

- Druckverband / Tourniquet
- Volumentherapie
- Medikamentöse Therapie (Katecholamine, Antiarrhythmika)
- Beckenschlinge

www.bzpg.de



53

ABCDE: Disability (neurolog. Defizit)

- Pupillen? (Reaktion/ Anisocorie)
- Blutzucker?
- Bewusstseinslage (GCS)?
- Intoxikation? Stoffwechselentgleisung?

Interventionen:

- Ursachenbehandlung

www.bzpg.de



54

ABCDE: Environment (Exploration)

- Ganzkörperuntersuchung (Body-/ Traumacheck)
- Temperatur? Hypothermieprophylaxe

www.bzpg.de



55

Glasgow-Koma-Skala

- Ursprünglich zum Einsatz bei Patienten mit aktuellem Schädel-Hirn-Trauma
- Allgemeine Einschätzung von Bewusstseinsstörungen
- Nicht anwendbar bei langfristig pflegebedürftigen/ desorientierten Menschen
- Unter 8 Punkte: schwere Störung des Bewusstseins
- Maximal erreichbare Punktzahl: 15

www.bzpg.de



56

Glasgow-Koma-Skala (GCS)

GCS	Augenöffnung	beste verbale Antwort	beste motorische Reaktion
6			Befolgt Aufforderungen
5		Orientierte Antwort	Gezielte Abwehrbewegungen bei Schmerz
4	Spontanes Öffnen der Augen	Verwirrte, desorientierte Antwort	Ungezielte Abwehrbewegungen bei Schmerz
3	Öffnen der Augen auf Ansprache	Unzusammenhängende Wörter	Beugesynergien (Zusammenwirken der Beugemuskulatur)
2	Öffnen der Augen auf Schmerzreize	Unverständliche Laute	Strecksynergien (Zusammenwirken der Streckmuskulatur)
1	Keine Reaktion	Keine verbale Reaktion	Keine Reaktion

www.bzpg.de


BZPG
 Bildungszentrum für Pflege
 und Gesundheit
 in der Städteregion Aachen

57

ISBAR-Übergabeschema – strukturierte Patient:innenübergabe

- Medical Error Studien zufolge als dritthäufigste Todesursache in den USA ⁽¹⁾
- 2/3 der Fehlerquelle = inadäquate Kommunikation (insbesondere Patientenübergabe und Notfallsituation) ⁽²⁾

Drei Problemfelder

- **Fehlerquelle Sender:** Sagt der Sender das, was er meint?
- **Fehlerquelle Empfänger:** Ist der Empfänger aufmerksam?
- **Problem des Übertragungswegs:** Ist der richtige Gesprächspartner gewählt?

Quellen: (1) Makary MA, Daniel M. Medical error – the third leading cause of death in the US. *BMJ* 2016; 353: (12139). doi:10.1136/bmj.12139, (2) Lazarowicz M, Treitzsch H, Prickner S. Human Factors in der Medizin. *Urologe A* 2017; 56: 97–113. doi:10.1007/s00120-016-0302

www.bzpg.de


BZPG
 Bildungszentrum für Pflege
 und Gesundheit
 in der Städteregion Aachen

58

ISBAR-Übergabeschema

von WHO und DGA empfohlen

- **I**dentifikation
Name, Alter, Geschlecht
- **S**ituation
Hauptsymptom, Zustand
- **B**ackground
Auffindesituation, Vorerkrankungen, Medikation, Allergie (SAMPLER-Schema)
- **A**ssessment
Vitalwerte, erfolgte Maßnahmen, Verlauf (ABCDE-Schema)
- **R**ecommendation
Ergänzungen, Empfehlungen, Nachfragen

<https://www.youtube.com/watch?v=84mEUL1X-mM>

www.bzpg.de


BZPG
 Bildungszentrum für Pflege
 und Gesundheit
 in der Städteregion Aachen

59

Fallbeispiel

Wir bringen euch den 34-jährigen Herrn Meier mit Zustand nach Krampfanfall bei bekannter Epilepsie und Valproat-Therapie mit Erstdiagnose 06/2012. Vor etwa 45 Minuten wurde der Patient von seiner Ehefrau mit generalisiertem tonisch-klonischem Krampfanfall vorgefunden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte laufender Krampfanfall. Vorerkrankungen: Epilepsie, Asthma bronchiale. Vormedikation: Valproat, Salbutamol bei Bedarf. Nach Gabe von 10 mg Midazolam i. v. konnte der Krampf erfolgreich durchbrochen werden. Zurzeit Atemwege frei mit Wendl-Tubus. SpO2 98 % unter O2 6 l/min via O2-Maske, sonst kein B-Problem. Tachykard mit 110/min, Blutdruck bei 150/90 mmHg, sonst kein C-Problem. Patient somnolent mit GCS 12/15, unscharf orientiert, BZ 95 mg/dL, Pupillen isocor, prompt konsensuell lichtreagibel, orientierende neurologische Untersuchung unauffällig. Temperatur 36,5 °C, Prellmarke am Hinterkopf. Die Ehefrau ist bei uns mitgefahren, sitzt im Warteraum und wartet auf eine Rückmeldung. Gibt es Fragen?

www.bzpg.de


BZPG
 Bildungszentrum für Pflege
 und Gesundheit
 in der Städteregion Aachen

60

Fallbeispiel: Lösung

Wir bringen euch den 34-jährigen Herrn Meier mit Zustand nach Krampfanfall bei bekannter Epilepsie und Valproat-Therapie mit Erstdiagnose 06/2012. Vor etwa 45 Minuten wurde der Patient von seiner Ehefrau mit generalisiertem tonisch-klonischem Krampfanfall vorgefunden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte laufender Krampfanfall. Vorerkrankungen: Epilepsie, Asthma bronchiale. Vormedikation: Valproat, Salbutamol bei Bedarf. Nach Gabe von 10 mg Midazolam i. v. konnte der Krampf erfolgreich durchbrochen werden. Zurzeit Atemwege frei mit Wendl-Tubus. SpO₂ 98 % unter O₂ 6 l/min via O₂-Maske, sonst kein B-Problem. Tachykard mit 110/min, Blutdruck bei 150/90 mmHg, sonst kein C-Problem. Patient somnolent mit GCS 12/15, unscharf orientiert, BZ 95 mg/dL, Pupillen isocor, prompt konsensuell lichtreagibel, orientierende neurologische Untersuchung unauffällig. Temperatur 36,5 °C, Prellmarke am Hinterkopf. Die Ehefrau ist bei uns mitgefahren, sitzt im Warteraum und wartet auf eine Rückmeldung. Gibt es Fragen?

Identification
Situation

Background

Assessment

Recommendation

www.bzpg.de



61

Exkurs: Closed-Loop-Kommunikation

Nach Aufforderung an ein Team-Mitglied, sollte die vollständige Bestätigung des Arbeitsauftrages erfolgen, um dem Sender ein Feedback zu geben, dass der Empfänger die Aufforderung nicht nur gehört sondern auch verstanden hat und somit ein „Gib mal 50“ - „Alles klar“ nicht im Desaster endet.

„Gib dem Patienten jetzt 40 mg Propofol, 4 ml“
„Ich gebe dem Patienten jetzt 40 mg Propofol“
„Ich habe dem Patienten 40 mg Propofol gegeben“

www.bzpg.de



62

Exkurs: Closed-Loop-Kommunikation



Gemeint ist nicht gesagt,
Gesagt ist nicht gehört,
Gehört ist nicht verstanden,
Verstanden ist nicht gemacht

www.bzpg.de



63

Beeinflussbare Faktoren einer Patient:innenübergabe

Beeinflussbare Faktoren, die sich negativ auf eine Patientenübergabe auswirken:

- Komplexe Hierarchien
- Angst (etwas falsches zu sagen)
- Zeitdruck
- Geräuschpegel
- Ablenkung
- Sprachbarrieren
- Fehlende Standards

- Praxisbeispiel: Schockraum

www.bzpg.de



64

Häufige Notfallsituationen (im stationären Akutsetting)

www.bzpg.de



65

Notfälle auf Station

- Interne Notrufnummer („Rea-Team“) kennen
- Wissen, wo der Notfallwagen/ Notfallkoffer ist (inkl. AED, Absaugung, Beatmungsbeutel, Reanimationsbrett)
- sich mit den Materialien vertraut machen und regelmäßig Prüfen (Funktionsfähigkeit/ Verfall)



www.bzpg.de



66

Reanimationsbrett

Bildquelle:
reaplan.de



www.bzpg.de



67

DNR / DNI

- DNR = Do Not Resuscitate = nicht Wiederbeleben
- DNI = Do Not Intubate = nicht Intubieren (Beatmung über einen ETT)
- Bestenfalls vor einem Notfall abklären, ob eine Patientenverfügung vorliegt und welchen Inhalt diese hat (Rücksprache mit dem ärztlichen Personal)
- In einer lebensbedrohlichen Situation ist oft keine Zeit, um solche Fragen zu klären

www.bzpg.de



68

Dyspnoe (Luftnot)

- **Atem- und Herzfrequenz** durch O₂-Mangel und CO₂-Anstieg **erhöht**
- Mögliche Symptome:
 - **Ringern nach Luft:** Der Patient versucht, möglichst viel Luft in die Lungen zu ziehen.
 - **Unruhe:** Angst, agitiert und veränderte Körperhaltung
 - **Zyanose:** bläuliche Verfärbung der Haut- und Schleimhäute (durch wenig O₂ am Hämoglobin = blauviolette Verfärbung)
 - **Nasenflügel:** Bei Säuglingen bewegen sich bei Dyspnoe typischerweise die Nasenflügel synchron zur Ein- und Ausatmung

www.bzpg.de



69

Dyspnoe (Luftnot)

Was nun?

- Patienten aufrecht, sitzend positionieren
- Alle beengenden Kleidungsstücke öffnen
- evtl. Fenster öffnen
- Atemunterstützende Lagerung
- O₂-Gabe (CAVE: O₂ ist ein Medikament)
- evtl. Bronchodilatoren

Worst case: generalisierter O₂-Mangel = Organschädigungen = Bewusstseinsstörung (Co₂-Narkose) = Atemstillstand = Herzstillstand

www.bzpg.de



70

Atemunterstützende Positionierungen

Oberkörperhochlagerung

- 30-40°-Winkel, Unterarme unterlagern
- Kontraindikationen: Kreislaufstörungen, Wirbelsäulenerkrankungen



Quelle: Schulte D. Atemunterstützende Positionierungen. In: I care Pflege. 2., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 2020. doi:10.1055/b-006-163255

www.bzpg.de



71

Atemunterstützende Positionierungen

Kutschersitz

- nach vorne gebeugt auf den vorderen Teil eines Stuhls
- Arme stützend auf einem Tisch / Oberschenkeln
- Dehnung des Brustkorbs → vergrößerte Atemfläche → tieferes Einatmen



Quelle: Schulte D. Atemunterstützende Positionierungen. In: I care Pflege. 2., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 2020. doi:10.1055/b-006-163255; Lungenliga

www.bzpg.de



72

Atemunterstützende Positionierungen

Torwartstellung

- Arme im Stehen mit gestrecktem Oberkörper und leicht angewinkelten Beinen auf die Oberschenkel abstützen



Quelle: Schulte D. Atemunterstützende Positionierungen, in: I care Pflege, 2., überarbeitete Auflage, Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2020, doi:10.1055/b-906-163255, Lungenliga

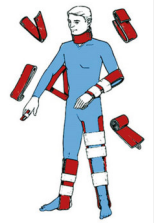
www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

73

Knochenbruch (#)

- Bruchstelle ruhigstellen (SamSplint®)
- Offener Bruch: mit aseptischer Wundauflage bedecken
- evtl. Behandlung des Schocks
- verletzte Gliedmaßen umpolstern
- PECH-Regel und DMS-Kontrolle anwenden



Bildquelle: hestomed Versandshop

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

74

DMS-Kontrolle

- Schnelle Überprüfung der Leitungsbahnen (Arterien, Venen, Nerven) nach Extremitätentrauma
- **D**urchblutung Nagelbettprobe (Hautkolorit und -temperatur)
- **M**otorik Bewegen der Zehen/Finger
- **S**ensibilität Wahrnehmen eines leichten Streichelns?

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

75

Rekapillarierungszeit (Recap-Zeit)



Bildquelle: Springer, Pädiatrie

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

76

PECH-Schema

- Sofortmaßnahmen bei geschlossenen Verletzungen des Bewegungsapparats
- **P**ause Abbruch der körperlichen Aktivität
- **E**is Kühlung mit Eis (CAVE: Kälteschäden)
- **C**ompression Verbands mit moderatem Druck
- **H**ochlagern Hochlagern der betr. Extremität

www.bzpg.de



77

Blutung und Blutstillung

Unterscheidung je nach Blutungsart:

- **Venöse Blutung:** dunkelrot, fließt gleichmäßig und ohne Druck aus der Wunde
- **Arterielle Blutung:** hellrotes Blut, spritzt stoßweise (im Rhythmus des Herzschlages) aus der Wunde
- **Kapillare Blutung:** oberflächliche Sickerblutung aus kleinsten Gefäßen

www.bzpg.de



78

Blutung und Blutstillung

Blutstillung erfolgt durch:

Endokrine (körpereigene) Faktoren:

- Blutgerinnung: Thrombozyten verschließen durch Thrombozytenaggregation das „Blutungsleck“
- Vasokonstriktion (Engstellen der Blutgefäße): durch glatte Gefäßmuskulatur verursacht

Exokrine (äußere) Faktoren:

- Hochlagerung der verletzten Gliedmaßen (Druckminderung im verletzten Gefäß)

www.bzpg.de



79

Blutung und Blutstillung

- Direkten Druck auf die Wunde: steriler Wundverband → Druckverband → Tourniquet (nur Oberschenkel und –arm – CAVE: Uhrzeit)



www.bzpg.de



80

Intoxikation (Vergiftung)

„Eine Intoxikation ist die schädliche Einwirkung einer chemischen, pflanzlichen, tierischen oder sonstigen Substanz auf den Organismus“

Quelle: Notfallmedizin, Kapitel 38, Thieme

www.bzpg.de



81

Intoxikation (Vergiftung)

Erste-Hilfe:

An Eigenschutz denken! Handschuhe? Gas?

- Vitalparameter prüfen, nach geschehen Fragen (SAMPLER-Schema)
- Bei Bewusstlosigkeit: Seitenlage
- Erbrochenes dem Rettungsdienst mitgeben
- Giftnotruf anrufen: **030 19240** (oder auch die gleiche Rufnummer mit der Vorwahl 0551, 06131, 06841, 0761 oder 089)
(Tipp: Nummer abspeichern)

www.bzpg.de



82

Hämatemesis (Bluterbrechen)

- Sofort Arzt rufen und Vitalzeichen erheben
- GI-Blutungen können zum Schock führen (erheblicher Blutverlust)
- Blutungsquelle im Magen/ Dünndarm: kaffeesatzartig/ schwarzes Erbrochene (Magensäure zersetzt das Blut)
- Frisches, rotes Blut: akute Blutung
- Blutstillung oft in der Endoskopie oder auf Intensivstation (Magenspiegelung)
- Kreislauf stabilisieren → Patienten transportfertig machen

www.bzpg.de



83

Hämatemesis (Bluterbrechen)

Erste Maßnahmen:

- Zu Pfleger bei Bewusstsein? In sitzende Position bringen, um Aspiration vorzubeugen
- Bewusstseinsverlust? Zu Pfleger in stabile Seitenlage bringen
- Gerinnungsparameter und Blutbild bestimmen

Nicht aufstehen! Kollapsgefahr!

- Zusätzliche Maßnahmen gem. Hypovolämischem Schock

www.bzpg.de



84

Amputation

„Die Amputation bezeichnet **die Abtrennung einer Gliedmaße vom Körper.**“

Quelle: <https://viamedici.thieme.de/learnmodul/8650800/4915581/amputation-und-prothetik>

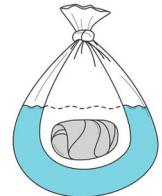
www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

85

Amputationsverletzung

- 1) Wunde hochhalten, abdrücken
- 2) Wunde bedecken
- 3) Druckverband anlegen, Notruf ansetzen
- 4) Abgetrenntes Körperteil sauber einwickeln
- 5) Nicht säubern
- 6) Kühl halten



www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

86

Augenverletzung

- Auge mit klarem Wasser ausspülen
- Auge mit dem Finger aufhalten
- nicht übers "gesunde Auge" spülen



www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

87

Schock

„Der Schock ist gekennzeichnet durch ein **akutes bis subakutes, fortschreitendes, generalisiertes Kreislaufversagen** mit konsekutivem **Missverhältnis** zwischen **Sauerstoffangebot** und **Sauerstoffbedarf** auf Zellebene und **lebensbedrohlicher Gefährdung der Vitalfunktionen.**“

Quelle: <https://viamedici.thieme.de/learnmodul/8659446/4915570/schock>

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

88

Schockformen

Welche Schockformen gibt es?

- **Hypovolämisch**
(durch Flüssigkeitsmangel oder Blutung)
- **Kardiogen**
(Myokardinfarkt, Klappenfehler, Rhythmusstörungen)
- **Distributiv**
(septisch, anaphylaktisch, neurogen)
- **Obstruktiv**
(Vena-cava-Kompressionssyndrom, Spannungspneu, LAE)

www.bzpg.de



89

Erstmaßnahmen beim Schock

- Unzureichende Atmung/ Kreislaufstillstand → CRP und Notruf
- Beseitigung der Schockursache
- Schockgerechte Lagerung (Schocklage bei erhaltenem Bewusstsein + suffizienter Atmung, jedoch nicht beim kardiogenen Schock)
 - Kopf und Oberkörper flach lagern, Beine schräg nach oben lagern durch Unterschieben eines geeigneten Gegenstands unter die Beine
- Unzureichende Atmung: O2-Gabe bis hin zur Beatmung
- Komplettes Monitoring

www.bzpg.de



90

Hypovolämischer Schock (Volumenmangel)

- **Kreislaufversagen wg. eines akuten Volumenmangels im Gefäßsystem**
- Durch starken Blutverlust (z. B. Trauma, innere Blutungen) sowie massive Flüssigkeitsverluste (z. B. schwere Verbrennungen, Dehydratation)
- **Pathophysiologie:** niedriges zirkulierendes Blutvolumen → reduzierte Herzauswurfleistung → unzureichende Perfusion und O2-Versorgung
- Klinik: Tachykardie, Hypotonie, blasse und kühle Haut, verlängerte Recap-Zeit, Bewusstseinseintrübung

www.bzpg.de



91

Hypovolämischer Schock (Volumenmangel)

- **Therapie:** Blutstillung, Volumenersatz (VEL oder Blutprodukte + Gerinnungstherapie), O2-Gabe, ggfs. Katecholamintherapie
- **Monitoring:** VZ, Urinausscheidung, Laktat, Hb

www.bzpg.de



92

Schockindex beim Hypovolämischen Schock

$$\text{Schockindex} = \frac{\text{Puls}}{\text{RR (systolisch)}}$$

- Schockindex bei gesunden Menschen = ca. 0,5
- Schockindex bei Schockgefahr > 1

Notfall: Schock wahrscheinlich bei Schweiß 3 x k (kalt, klebrig, kleinperlig) + Tachykardie + Apathie

www.bzpg.de



93

Kardiogener Schock (Pumpversagen)

- **Akutes Pumpversagen des Herzens mit unzureichender Organperfusion (in 80 % = akuter Myokardinfarkt)**
- **weitere Ursachen:** schwere Herzrhythmusstörungen, Klappeninsuffizienz, Myokarditis
- **Pathophysiologie:** verminderte Kontraktion des Herzens → reduzierte Herzauswurfleistung → unzureichende Perfusion und O₂-Versorgung

www.bzpg.de



94

Kardiogener Schock (Pumpversagen)

- **Klinik:** Tachykardie, Hypotonie, blasse und kühle Haut, Oligurie, Bewusstseinsstörungen
- **Therapie:** Kausal (bspw. Intervention der Koronarien bei Myokardinfarkt), medikamentöse Unterstützung, ECMO, Beatmung bei resp. Insuffizienz
- **Monitoring:** EKG, Echo, Labor (Trop. + Laktat), TEE

www.bzpg.de



95

Distributiver Schock (Volumenmangel)

- **Schockform charakterisiert durch pathologische Vasodilatation und Fehlverteilung des Blutvolumens (Verteilungsstörung des Blutvolumens = Situationen, in denen Blutgefäße sich inadäquat weiten)**
- **Hauptformen:** septisch (Fieber/ Hypothermie, Leukozytose/ -penie), anaphylaktisch (Angioödem, Bronchospasmus), neurogen (Bradykardie, RM-Verletzungen)

www.bzpg.de



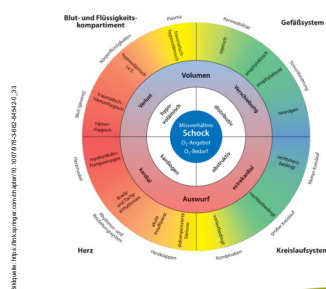
96

Distributiver Schock (Volumenmangel)

- **Pathophysiologie:** verminderte Kontraktion des Herzens → reduzierte Herzauswurfleistung → unzureichende Perfusion und O₂-Versorgung
- **Klinik:** Tachykardie, Hypotonie, Oligurie, Bewusstseinsstörungen + warme, gerötete Haut
- **Therapie:** Kausal (bspw. Adrenalin bei Anaphylaxie), medikamentöse Unterstützung

Obstruktiver Schock (mech. Behinderung)

- **mechanische Behinderung des venösen Rückstroms oder der kardialen Auswurfleistung (Blockade größerer Gefäße oder des Herzens)**
- **Hauptsachen:** LAE, Spannungspneumothorax, Perikardtamponade
- **Klinik:** Tachykardie, Hypotonie, Oligurie, Bewusstseinsstörungen + gestaute Halsvenen
- **Therapie:** Kausal (bspw. LAE = Antikoagulation, Thrombolyse/ Spannungspneu = Entlastungspunktion/ Perikardtamponade = Punktion oder Drainage), medikamentöse Unterstützung



Durchschnittsalter reanimierter Patienten
Was denken Sie?

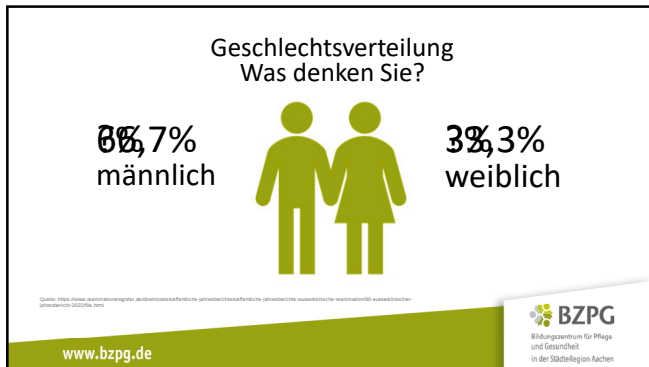
70,2
Jahre
Durchschnittsalter

1,3%

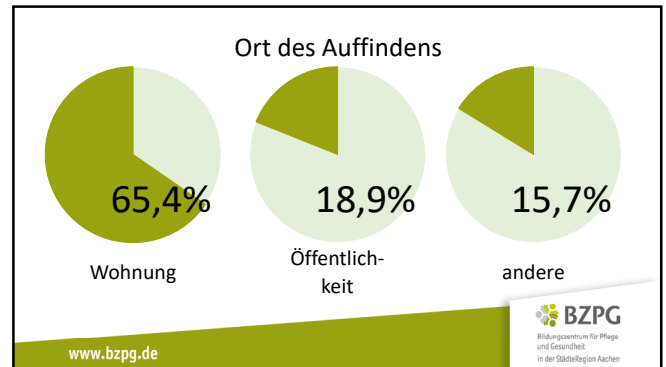
jünger als 80 Jahre

34,3%

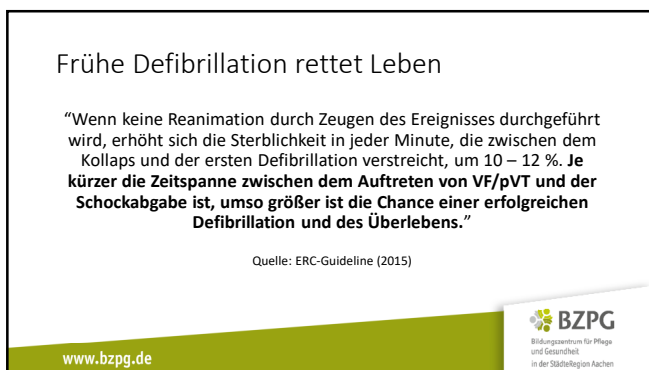
älter als 80 Jahre



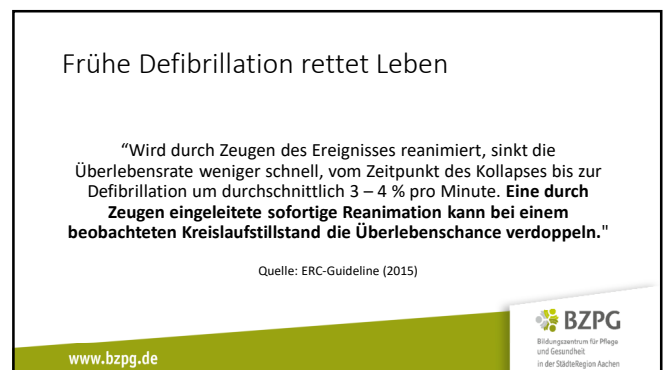
101



102



103



104

Basic Life Support (Basisreanimation)

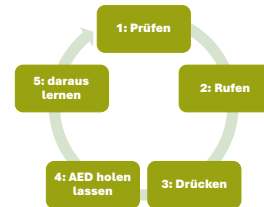


www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

105

5 Kernaussagen der BLS-Laienreanimation



www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

106

Laienreanimationsquote



Abbildung 1 Laienreanimationsquote in Deutschland (eigene Darstellung nach Fischer et al., 2018, 2022)

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

107

Laienreanimationsquote

www.bzpg.de



Reanimationsversorgung geht uns alle an!



www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

108

Innerklinischen Notruf absetzen

Wie meldet man einen innerklinischen Notfall?

- Laut und bestimmt um Hilfe rufen
- Notrufnummer wählen (lassen und kennen)
- "W-Fragen" beantworten
- Auf Rückfragen warten

Wie lautet die Notrufnummer in den verschiedenen Krankenhäusern?

www.bzpg.de



109

Basisreanimation durchführen

Eigenschutz geht vor!

Jede Minute zählt!

www.bzpg.de



110

Basismaßnahmen – Step-by-Step

- **Sicherheit**
Helfer und Patienten sollen in Sicherheit sein
- **Reaktion - Ansprechbarkeit überprüfen**
Schütteln und Fragen: "Ist alles in Ordnung?"
- **Atemweg – Atemwege öffnen**
keine Reaktion? Patient auf den Rücken legen + Atemwege öffnen

www.bzpg.de



111

Basismaßnahmen – Step-by-Step



1. Eine Hand auf die Stirn, die andere Hand mit den Fingerspitzen auf die Kinnspitze
2. Kopf sanft Nackenwärts ziehen zum Öffnen der Atemwege

Quelle: Reanimation im außerklinischen Umfeld: Basismaßnahmen (Basic Life Support) - BLS in 1-Lern-Modulversionen, 2., überarbeitete Auflage, Stuttgart: Thieme, 2020, S. 154-155, 166-172, 174

www.bzpg.de



112

Basismaßnahmen – Step-by-Step



nur bei V. a. Wirbelsäulentrauma: Esmarch-Handgriff

Quelle: Reanimation im außerklinischen Umfeld: Basismaßnahmen (Basic Life Support = BLS). In: [care Krankheitslehre, 2., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2020. doi:10.1055/b-006-163256]

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

113

Basismaßnahmen – Step-by-Step

Atmung fehlt oder ist nicht normal

- Rettungsdienst alarmieren (lassen)
- Patienten nur verlassen, wenn nicht anders möglich
- Lautsprecher aktivieren am Telefon

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

114

Basismaßnahmen – Step-by-Step

Atmung – Sehen, Hören, Fühlen

- Atmung durch Sehen, Hören und Fühlen nicht länger als 10 Sek. Kontrollieren
- in den ersten Minuten nach Kreislaufstillstand sind keine/kaum/vereinzelte Atemgeräusche möglich = keine normale Atmung



www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

115

Basismaßnahmen – Step-by-Step

AED holen lassen

- AED durch andere Person holen lassen
- wenn alleine: sofort Reanimation starten



www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

116

Basismaßnahmen – Step-by-Step

Thoraxkompressionen starten

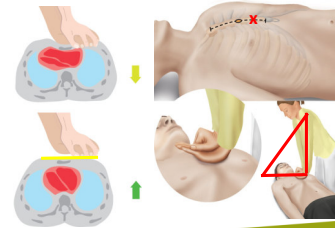
- Neben den Patienten knien
- Einen Handballen auf die untere Mitte des Sternums legen
- Die andere Hand auf die erste Hand legen, Finger verschränken
- Arme grade halten und Schultern senkrecht über den Brustkorb halten
- Brustbein 5-6 cm drücken
- Frequenz: 100-120x/Minute
- Dazwischen: Brustbein vollständig entlasten, Hände jedoch auf dem Sternum behalten

www.bzpg.de



117

Basismaßnahmen – Step-by-Step



5-6 cm Tief
x 100-120/min

Quelle: Schulze D. Kardioresuscitation/Reanimation/
CPR zum Einsteigen, 4. Aufl. 2019, S. 2.
überarbeitete Auflage, Stuttgart:
Thieme 2019, doi:10.1055/b-005-163255

www.bzpg.de



118

Basismaßnahmen – Step-by-Step

Thoraxkompressionen weiterführen, Atemspende geben

- Nach 30 Kompressionen die Atemwege durch Überstrecken des Halses und Anheben des Kinns freimachen
- Normal Einatmen und Lippen auf Mund des Patienten legen (Abdichten!)
- Gleichmäßig in den Mund blasen, der Brustkorb sollte sich (wie bei einer normalen Atmung) rund 1 Sekunde heben

www.bzpg.de



119

Basismaßnahmen – Step-by-Step

- Erneut Einatmen und nochmal in den Patientenmund blasen (insgesamt zwei Atemspenden)
- Nicht mehr als 10 Sekunden für die Atemspenden benötigen auch, wenn diese Ineffektiv waren
- Weiter mit Thoraxkompressionen und Beatmung im Verhältnis 30:2 fortfahren

www.bzpg.de



120



121

4H's

Mögliche reversible Ursachen eines Herz-Kreislauf-Stillstands

- Hypoxie → O₂-Gabe / Atemwegssicherung
- Hypovolämie (Volumenmangel) → Volumensubstitution
- Hypo- / Hyperthermie → Kühlen/Wärmen
- Hypo- / Hyperkaliämie
 - Hyperkaliämie: Kardioprotektion + forcierte Diurese (z. B.: Furosemid (Schleifendiuretikum, CAVE: Kaliumsparende Diuretika)) + Verschiebung nach intrazellulär (Insulin, Glukose, Salbutamol, NaBi)

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

122

HITS

Mögliche reversible Ursachen eines Herz-Kreislauf-Stillstands

- Herzbeuteltamponade → Perikardpunktion
- Intoxikation → Antidot
- Thromboembolie → Thrombolyse
- Spannungspneumothorax → Entlastungspunktion / Thoraxdrainage

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

123

Triage in der Notaufnahme

Begriffsdefinition Triage (im Kontext der Notaufnahme):

“Identifizierung bzw. **Priorisierung** der notfallmäßig aufgenommenen Patienten **nach der Dringlichkeit der Behandlungsnotwendigkeit.**“

Quelle: Pflege Heute, Kap. 14: Pflege in Notfallsituationen

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

124

Triage in der Notaufnahme

Informieren Sie sich über Triage in der Notaufnahme, insbesondere zum Manchester Triage System (MTS).

Erledigen Sie anschließend den Arbeitsauftrag.

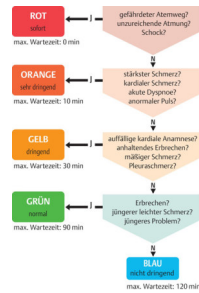
www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädtelRegion Aachen

125

Manchester Triage System (MTS)

- Ersteinschätzung findet in der Notaufnahme statt
- Indikatoren (Hinweise) werden angefragt
- Sobald ein Indikator feststeht = Triage erfolgt
- Diagramme fangen mit der höchsten Dringlichkeitsstufe an



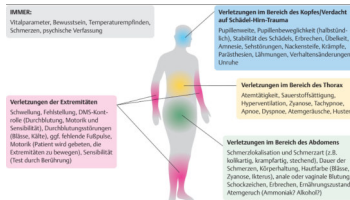
Quelle: Schulze D. 21.5.3 Die traumatische Notaufnahme. In: i care Pflege. 2., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2020. doi:10.1055/b-006-163255

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädtelRegion Aachen

126

Beobachtungskriterien bei Traumata



Quelle: Schulze D. 21.5.3 Die traumatische Notaufnahme. In: i care Pflege. 2., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2020. doi:10.1055/b-006-163255

www.bzpg.de

BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädtelRegion Aachen

127